



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**TOR (*TERM OF REFERENCE*)
PELATIHAN PENYIAPAN OBAT
INTRAVENA DAN TEKNIK ASEPTIK
TAHUN 2025**



TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PENYIAPAN OBAT INTRAVENA DAN TEKNIK ASEPTIK
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 pasal 40 ayat 1, Rumah Sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Akreditasi Rumah Sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, standar akreditasi rumah sakit yang diterbitkan Kemenkes Republik Indonesia tersebut digunakan sebagai acuan bagi Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan akreditasi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI terdiri dari 16 bab salah satunya adalah Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO). Pada standar PKPO 5 menyebutkan bahwa untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan pada pasien maka rumah sakit diminta menyiapkan dan menyerahkan obat dalam lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan lingkungan serta untuk mencegah kontaminasi tempat penyiapan obat harus sesuai peraturan perundang-undangan dan praktik profesi.

Fokus pelayanan kefarmasian bergeser dari kepedulian terhadap obat (*drug oriented*) menuju pelayanan optimal setiap individu pasien tentang penggunaan obat (*patient oriented*). Untuk mewujudkan *pharmaceutical care* dengan risiko yang minimal pada pasien dan petugas kesehatan perlu penerapan manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan bagian yang mendasar dari tanggung jawab pemberian pengobatan. Manajemen obat mencakup sistem dan proses yang digunakan rumah sakit dalam memberikan farmakoterapi kepada pasien. Hal ini merupakan upaya multidisiplin apoteker dalam menerapkan *dispensing* sediaan steril.

Dispensing sediaan steril harus dilakukan dalam ruang yang bersih (*clean room*) yang dilengkapi dengan *laminar air flow* dan petugas yang sudah terlatih dengan teknik aseptis serta menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kesalahan *dispensing* merupakan faktor yang bisa meningkatkan *medication errors*. Demi mencegah terjadinya *medication errors* maka diperlukan pelatihan secara berkala mengenai *dispensing* sediaan steril yang dilakukan sesuai dengan praktek profesi.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril terlatih dan kompeten.

B. Tujuan

a. Tujuan Instruksional Umum

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga pelayanan kesehatan tentang prinsip penyiapan obat IV dan teknik aseptik

b. Tujuan Instruksional Khusus



1. Peserta terampil melakukan penyiapan obat IV dan teknik aseptik.
2. Peserta terampil teknik pencampuran obat IV.
3. Peserta memahami kompatibilitas sediaan IV.
4. Peserta memahami stabilitas obat rekonstitusi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan mengurangi kejadian *medication error* yang disebabkan karena ketidaktepatan dalam penyiapan obat IV dan teknik aseptik.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 SUSUNAN PANITIA

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Sekretaris	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
3	Moderator	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir: ringkasan persesi dan tanya jawab
4	Absensi	Susan rahmawati, S.Sos	bertanggung jawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelathan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan
5	Sie Dokumentasi	apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir: foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
8	Sie Pretest dan Posttest	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	bertanggung jawab terhadap pembagian, pelaksanaan, penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test

2.2 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik dilaksanakan 1 (satu) hari dibagi menjadi 2 gelombang.

Tanggal : 08 Desember 2025

Pukul : Gelombang I : 08.00 s/d 10.00 WIB

Gelombang II : 14.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

2.3 RENCANA RAPAT PANITIA PENYELENGGARAAN

JUDUL MATERI	SASARAN	NARASUMBER	METODE	PERLENGKAPAN	FREKUENSI PELAKSANAAN	DASAR MATERI	OUTPUT TRAINING	TARGET TRAINING JANGKA PANJANG
Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik	1. Apoteker 2. Tenaga Vokasi Farmasi 3. Perawat 4. Bidan	1. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm 2. apt. Fadilah Maulana Irham A., S. Farm	a. Pre-Post Test b. Presentasi c. Diskusi d. Demonstrasi Video e. Tanya Jawab f. Praktek	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Alat dan Bahan : (Sput 10 cc, spuit 3 cc, alcohol swab, kasa steril, parafilm, pinset, vial antibiotik, ampul kaca, HS non steril, WFI 25 ml.	1x / tahun	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024. PKPO 5 Tentang Akreditasi Rumah Sakit "Penyiapan obat dilakukan oleh staf yang terlatih dalam lingkungan yang aman bagi pasien, staf dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik kefarmasian untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiatnya".	a. Meningkatkan pemahaman apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, dan bidan dalam menyiapkan obat IV dan teknik aseptik. b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan mengurangi kejadian medication error yang disebabkan karena ketidaktepatan dalam penyiapan obat IV dan teknik aseptik. c. Kenaikan nilai post test terhadap pre test	1. Paham tentang prinsip penyiapan obat IV dan teknik aseptik. 2. Paham tentang teknik pencampuran obat IV 3. Paham tentang kompatibilitas sediaan IV 4. Paham tentang stabilitas obat rekonstitusi 5. Tenaga vokasi farmasi dapat melakukan dispensing sediaan steril
Pencampuran Obat Intravena						b. Prinsip penyiapan obat IV dan teknik aseptik		
Stabilitas Penyimpanan Obat Intravena						c. Permasalahan penyiapan sediaan IV. d. Kompatibilitas sediaan IV e. Stabilitas obat rekonstitusi f. Teknik pencampuran obat IV		

Outline Training

NO	OUTLINE	ISI PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	MC
2	Pre test	QR code pre test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
3	Susunan acara	Tabel rundown acara training	MC
4	Judul	Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik	Narsum
5	Latar Belakang	Tampilkan data terkait permasalahan penyiapan obat intravena dan teknik aseptik, ketidaksesuaian dosis di DPO dan resep di RS Prima Husada, bila data tidak lengkap, dapat menampilkan temuan kasus-kasus terkait, Munculkan fakta-fakta riil di lapangan terkait ketidaksesuaian temuan.	Narsum
6	Target	1. Apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, dan bidan memahami prinsip penyiapan obat IV dan teknik aseptik. 2. Apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, dan bidan memahami tentang teknik pencampuran obat IV 3. Apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, dan bidan memahami tentang kompatibilitas sediaan IV 4. Apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, dan bidan memahami tentang stabilitas obat rekonstitusi 5. Tenaga vokasi farmasi dapat melakukan dispensing sediaan steril	Narsum
7	Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik	1. Pengertian teknik aseptik dan pencampuran obat intravena 2. Tujuan teknik aseptik dan pencampuran obat intravena 3. Sumber kontaminasi yang bisa terjadi 4. Kontaminasi silang 5. Permasalahan penyiapan sediaan intravena 6. Persyaratan sediaan intravena	Narsum
8	Pencampuran Obat Intravena	1. Persiapan pencampuran obat intravena 2. Peralatan yang dibutuhkan 3. Ruangan/ lingkungan sesuai regulasi 4. APD dan petugas 5. Prinsip pencampuran obat 6. Cara memegang spuit sesuai teknik aseptik 7. Critical point 8. Teknik pencampuran obat intravena 9. Teknik memindahkan obat dari ampul	Narsum

		10. Teknik rekonstitusi sediaan serbuk vial 11. Menampilkan video cara pencampuran obat intravena	
9	Stabilitas Penyimpanan Obat Intravena	1. Beyond use date 2. Data stabilitas obat rekonstitusi (menampilkan tabel)	Narsum
10	Diskusi	1. Tanya jawab terkait materi 2. Kesulitan-kesulitan yang selama ini dialami di lapangan terkait materi diklat	Narsum Moderator
11	Kesimpulan	Penekanan pada hal-hal yang harus dilakukan setelah ini	Moderator
12	Post Test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
13	Role Play	Memindahkan obat dari ampul dan rekonstitusi sediaan serbuk vial menggunakan berbagai bahan dan alat dalam berbagai setting	Panitia

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

NO	LANGKAH	PJ	YANG TERLIBAT
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Komite Keperawatan & Kebidanan Instalasi Farmasi
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Hasil materi di CC ke SDM
3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Narasumber
5	Menentukan moderator training	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	PJ Bab PKPO
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	PJ Bab PKPO
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	PJ Bab PKPO



8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	PJ Bab PKPO
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Panitia

2.4 SASARAN ATAU PESERTA

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Apoteker	12
2	TTK	26
3	Perawat - Bidan	174
TOTAL		212

2.5 SUSUNAN ACARA LENGKAP

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
Gelombang I			
08.00-08.05 WIB	5 menit	Pretest	Tim
08.05-09.55 WIB	80 menit	Materi 1. Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik 2. Pencampuran Obat Intravena 3. Stabilitas Penyimpanan Obat Intravena	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
09.55-10.00 WIB	5 menit	Post test	Tim
Gelombang II			
14.00-14.05 WIB	5 menit	Pretest	Tim
14.05-15.55 WIB	80 menit	Materi 1. Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik 2. Pencampuran Obat Intravena 3. Stabilitas Penyimpanan Obat Intravena	apt. Fadilah Maulana Irham A., S. Farm
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
15.55-16.00 WIB	5 menit	Post test	Tim

2.6 NARASUMBER

1. apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm
2. apt. Fadilah Maulana Irham A., S. Farm

2.7 MEDIA

- a. LCD
- b. Laptop
- c. Sound system
- d. Alat dan Bahan (Sput 10 cc, spuit 3 cc, alcohol swab, kasa steril, parafilm, pinset, vial antibiotik, ampul kaca, HS non steril, WFI 25 ml)

2.8 METODE

- g. Pre-Post Test
- h. Presentasi
- i. Diskusi
- j. Demonstrasi Video
- k. Tanya Jawab
- l. Praktek



2.9 KEBUTUHAN ANGGARAN

NO.	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN (RP)	HARGA (RP)	SUMBER DANA
1	Snack pameri	2 kardus	Rp 10.000	Rp 20.000	Dapur RSPHM
2	Aqua botol	2 botol	Rp 5000	Rp 10.000	Dapur RSPHM
3	Aqua gelas	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000	Dapur RSPHM
4	Sertifikat	212	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy oleh SDM
Total				Rp 130.000	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 130.000	

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 MONITORING

NO	BAHASAN DAN KEGIATAN	PJ	YANG TERLIBAT/ YANG MASUK PANITIA
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	PJ Training
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	SDM	PJ Training
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	SDM	Ketua Komite terkait

3.2 EVALUASI

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PENDEK			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test dan post test serta praktek	apt. Asharul Fahrizi, S. Farm	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	SDM

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PANJANG			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	SDM dan PJ Bab PKPO
2	Hasil supervisi dibahas di rapat koordinasi	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	PJ Bab PKPO
3	Membuat RTL-TL-Evaluasi secara berkala	apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm	PJ Bab PKPO



IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada Malang

Dokumen ditandatangani secara
elektronik. Gunakan Pembaca
Tandatangan Elektronik Untuk
Verifikasi Dokumen Ini

Susan Rahmawati, S.Sos

Malang, 25 November 2025

Ketua Panitia,

Dokumen ditandatangani secara
elektronik. Gunakan Pembaca
Tandatangan Elektronik Untuk
Verifikasi Dokumen Ini

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Disetujui oleh,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes